

Intégration 1

Site: [Moodle Université de Genève](#)
Cours: Compétences cliniques en 2e année Bachelor
Livre: Intégration 1

Imprimé par: Damien Fulliquet
Date: jeudi 8 mai 2025, 11:36

Table des matières

1. Organisation

2. Déroulement et objectifs spécifiques de la session

2.1. Prise de l'anamnèse

2.2. Pratique de l'examen physique

3. Scénario pour le jeu de rôle /histoire de cas réel

4. Références

1. Organisation

Personne concernée

Responsable du séminaire :

- Pr Marco Roffi, médecin adjoint agrégé, Bip 079/ 55.33.391

Thème du séminaire

Problème de dyspnée d'origine cardiaque versus pulmonaire.

Objectifs généraux

Les objectifs d'apprentissage et les compétences visées sont [consultables en ligne sur LOOOP](#).

Méthode d'enseignement

- Session de deux heures.
- Groupe de huit étudiants par formateur.
- Pratique de l'anamnèse (jeu de rôle avec le moniteur) et de l'examen physique par les étudiants entre eux.

2. Déroulement et objectifs spécifiques de la session

Le but de ce séminaire est que l'étudiant apprenne:

- A **orchestrer** des éléments de l'anamnèse et de l'examen physique qu'il (elle) a jusqu'alors appris séparément, dans le cadre des Unités « Coeur et Circulation » et « Respiration ».
- Le séminaire est donc consacré à l'anamnèse d'un patient se plaignant d'une dyspnée progressive (jeu de rôle avec le formateur). Puis, le formateur démontre l'examen physique **intégré** des systèmes cardio-vasculaire et respiratoire sur un étudiant, en insistant sur les éléments prioritaires, et sur une séquence optimisant le confort du patient. Il est important que les étudiants pratiquent ensuite entre eux, car voir faire faire...

S'il reste du temps, le formateur peut amener les étudiants auprès d'un patient.

2.1. Prise de l'anamnèse

A l'issue du séminaire, l'étudiant(e) devrait être capable de :

- Reconnaître le caractère non spécifique de la dyspnée.
- Rechercher des éléments anamnestiques qui permettraient de discriminer entre une origine cardiaque et respiratoire de la dyspnée:
 - en faveur d'une origine cardiaque: anamnèse d'antécédents cardiaques (pathologie préexistante), facteurs de risque cardiovasculaires, orthopnée, dyspnée paroxystique nocturne, œdèmes des membres inférieurs vespéraux, prise de poids récente.
 - en faveur d'une origine respiratoire: facteurs de risque pour un syndrome obstructif chronique (tabac), anamnèse de bronchite chronique, absence d'orthopnée.
- Relever le caractère relatif de ces éléments: un insuffisant respiratoire ayant un cœur pulmonaire chronique peut avoir des symptômes d'insuffisance cardiaque droite ; certains patients porteurs d'une pathologie respiratoire peuvent être orthopnéiques (dysfonction plus importante du diaphragme en position couchée en cas de fatigue musculaire respiratoire); le tabac est un facteur de risque aussi bien sur le plan cardio-vasculaire que pour certaines pathologies respiratoires.
- Intégrer les anamnèses cardio-vasculaire et respiratoire.

2.2. Pratique de l'examen physique

Les éléments du status cardio-vasculaire et respiratoire ayant déjà été appris par l'étudiant(e) au cours des Unités " Circulation " et " Respiration ", le but de l'examen est ici l'intégration des gestes propres à l'examen de ces deux systèmes.

A l'issue du séminaire, l'étudiant(e) devrait donc être capable de pratiquer un examen intégré comprenant les éléments suivants:

- Une inspection générale afin d'évaluer: la fréquence respiratoire, la coloration de la peau, le pouls jugulaire, la présence d'un tirage sus-sternal et un examen des extrémités (les mains surtout, le patient n'étant que partiellement déshabillé) à la recherche d'une cyanose périphérique et d'une froideur.
- Un status cardio-vasculaire en position couchée à 45 degrés, avec au minimum:
 - l'inspection de l'aire cardiaque et du pouls jugulaire;
 - la palpation de l'aire précordiale, du choc de pointe, et du pouls carotidien;
 - l'auscultation cardiaque aux quatre foyers en décubitus dorsal, et en décubitus latéral gauche à la recherche d'un B3 ou d'un B4.
- Un status respiratoire en position assise avec au minimum:
 - l'inspection des mouvements respiratoires et du type de respiration ;
 - la palpation avec l'évaluation de l'ampliation thoracique et des vibrations vocales;
 - la percussion et l'auscultation postérieure et antérieure.

3. Scénario pour le jeu de rôle /histoire de cas réel

M. E. Soufflé :

- Patient de 64 ans, ayant occupé une multitude d'emplois, dont aucun qualifié. Actuellement chômeur en fin de droit, vivant d'une aide sociale et d'un petit soutien financier de son fils.

Antécédents personnels :

Aucun, en particulier pas de rhumatisme articulaire aigu.

Anamnèse actuelle :

M. E. Soufflé présente depuis six mois une dyspnée d'effort progressive, avec depuis deux mois une orthopnée, une dyspnée paroxystique nocturne. Il s'est mis à tousser aussi la nuit. Ses chevilles (surtout la droite) ont gonflé. Il doit se lever deux fois au cours de la nuit pour aller uriner.

Anamnèse systématique :

Modification du poids? (ne se pèse pas). Pas d'état fébrile. Pas de claudication intermittente, ni d'angor. Pas de syncope. En revanche, bronchite chronique depuis des années.

Habitudes :

Le patient est un gros fumeur (80 Unités/Paquet/Année (UPA)).

Consommation d'alcool niée par le patient. Pas de médicaments.

Le formateur peut, s'il le désire, dire aux étudiants ce que le status a révélé de pathologique chez ce patient, en démontrant le status sur un étudiant.

Status :

EG moyen, patient inquiet. FR 20/l. Pas de cyanose. TA 100/60 mmHg aux deux bras. Pouls régulier à 96/min. B1 et B2 inaudibles. Souffle protomésosytolique 3/6 râpeux au foyer aortique, irradiant dans les carotides. Souffle holosystolique 2/6 à l'apex irradiant dans l'aisselle. Pouls jugulaire à 12 cm de la fourchette sternale à 60 degrés. Montée carotidienne lente. Artères périphériques toutes palpables et sans souffle. Œdèmes des membres inférieurs remontant jusqu'à la cuisse, prenant le godet. Diamètre antéro-postérieur du thorax élargi. Expirium discrètement prolongé. Sibilances expiratoires. Râles crépitants inspiratoires aux deux bases pulmonaires.

La suite du cas est facultative.

Radiographie du thorax :

Cardiomégalie, redistribution vasculaire, lignes de Kerley B. Pas d'épanchement pleural.

Electrocardiogramme:

Rythme sinusal régulier. Hypertrophie ventriculaire gauche.

Echocardiographie, résultat :

Ventricule gauche: diminution homogène modérée à sévère de la fonction systolique avec une fraction d'éjection estimée visuellement à 30%.

Valve aortique: épaissement modéré. Insuffisance discrète. Sténose importante avec une vitesse maximale de 4.4 m/s, gradient moyen de 50 mmHg permettant de calculer une surface à 0.5 cm².

Valve mitrale: insuffisance modérée.

Conclusion :

- Insuffisance cardiaque décompensée sur sténose aortique sévère.
- Insuffisance mitrale modérée.
- Possible syndrome obstructif.

4. Références

Lectures obligatoires

- Bickley LS, Szilagyi PG. **Bates' guide to physical examination and history taking**. 12th ed. Philadelphia : Wolters Kluwer ; 2017. WB 205 1
 - *Révision des chapitres de sémiologie respiratoire et cardio-vasculaire*
 - Vidéos d'accompagnement : <http://batesvisualguide.com>
- M.H. Swartz. **Manuel de diagnostic clinique: historique et examen physique**. 2ème édition, Paris. Maloine, 2003, révision des chapitres de sémiologie respiratoire et cardio-vasculaire, WB 200 19 ed 2.